

31. MEP TRACTO GASTROINTESTINAL 1 : DELIMITACIÓN DEL EMBRIÓN

DURACIÓN : 05:35

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda en profundidad la formación del tracto gastrointestinal, así como la delimitación del embrión, centrándose en el desarrollo del estómago, el duodeno y el colon. Se exploran conceptos clave como la sincronicidad del desarrollo, la dinámica de los movimientos tridimensionales y la importancia del diafragma para la delimitación. Se detallan las relaciones entre los diferentes órganos, el peritoneo y las estructuras asociadas, incluyendo elementos como el mesogastrio y los epiplones. Este contenido ofrece una base sólida para cualquier práctica terapéutica, subrayando la importancia de una comprensión integral de los procesos embriológicos en la osteopatía.

ESTABLECIMIENTO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL Y DELIMITACIÓN DEL EMBRIÓN

Vamos a estudiar el **establecimiento** del **tracto gastrointestinal**, de la **cavidad peritoneal** y del **peritoneo** en el desarrollo del estómago, del duodeno, del intestino y del colon.

Comencemos por comprender el desarrollo del estómago en relación con el **hígado**, el **bazo** y el **páncreas**. Es esencial captar la fase inicial, que se denomina la **delimitación del embrión**. Hemos observado la integración del **celoma externo** en un **celoma interno**. En esta etapa, podemos ver la integración de la cavidad peritoneal, tanto en el plano sagital como transversal.

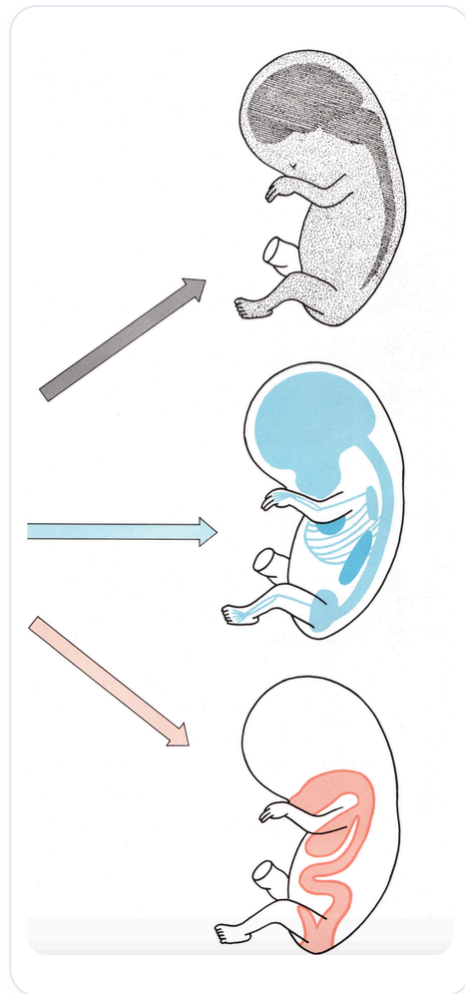


FIG. — *Hojas embrionarias*

No olviden la **sincronicidad** del desarrollo. El crecimiento es el gran motor de este proceso, con la formación de nuestro cuerpo en un orden primitivo. El crecimiento global del embrión, su enrollamiento y su retorno hacia la línea media son movimientos tridimensionales, e incluso en la **quinta dimensión**. La cuarta dimensión representa el tiempo, mientras que la quinta dimensión se refiere al componente **energético** y **eléctrico** que subyace a todo el sistema.

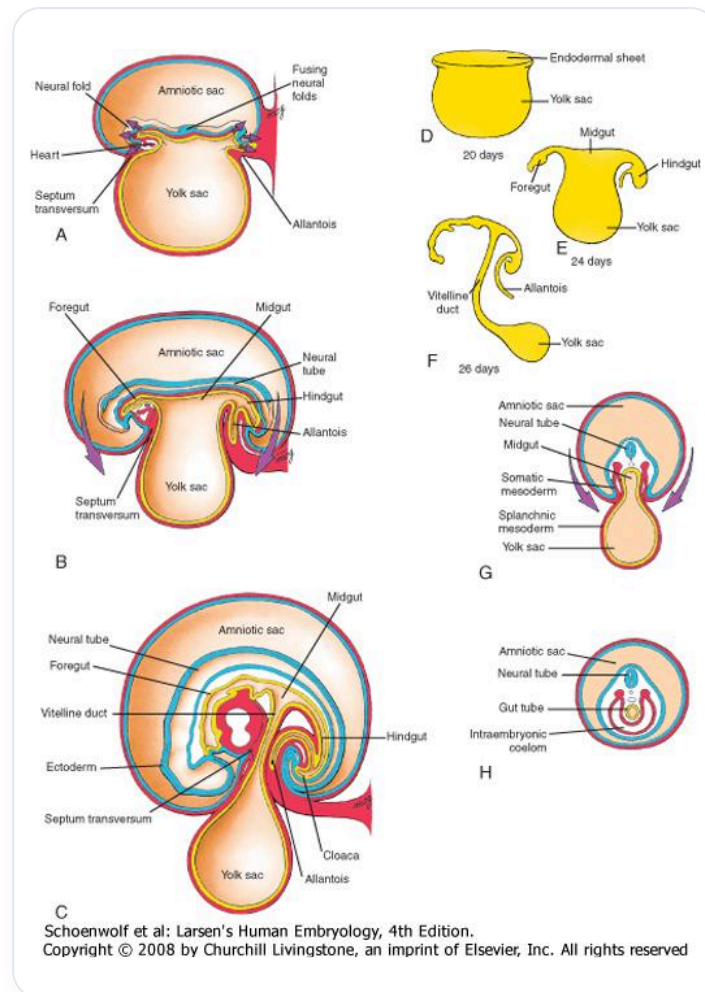


FIG. — Plegamiento embrionario lateral

Este movimiento siempre está integrado en la fase de **ascensión del ectodermo** y de **descenso relativo del endodermo**, con una fase casi a nivel del corazón. La ascensión del ectodermo y el descenso del endodermo, así como la integración del corazón, estiran las **arcadas** de la musculatura diafragmática y de los futuros músculos anteriores del cuello. Para tratar y reorganizar este espacio, es crucial comprender que hay que tratar y liberar el **diafragma**, ya que es él quien crea esta delimitación global.

La ascensión del **tubo neural**, el desarrollo de la cavidad peritoneal y el establecimiento del corazón forman un movimiento que se reintegra globalmente hacia un punto de apoyo llamado el **cordón umbilical**. Este cordón contiene la historia de este desarrollo, de esta delimitación y de esta reorganización del peritoneo.

Este proceso se integra en movimientos de **rotación específicos**, organizados en sentidos horario y antihorario. En un plano frontal, observamos un movimiento de desarrollo global **antihorario**, mientras que en un plano transversal, el movimiento es **horario**. La cavidad peritoneal comienza a organizarse y a delimitarse, lo que implica que va a moverse.

El peritoneo rodea un órgano, lo que se denomina un **peritoneo visceral**. Cuando un peritoneo conecta un órgano con la parte posterior, se llama un **meso**. Por ejemplo, para el estómago, se llama un **mesogastrio**, para el duodeno, un **mesoduodeno**, y para el colon, un **mesocolon**.

Dependiendo de la localización, también puede designarse como una **fascia de Tholt**. Para el intestino delgado, se habla de un **mesenterio**.

El peritoneo en la parte posterior se llama **peritoneo parietal posterior**, mientras que en la parte lateral, se designa como **peritoneo parietal anterior**. Si un peritoneo conecta un órgano con otro órgano, se llama un **epiplón**. Por ejemplo, el epiplón menor conecta el hígado con el estómago, y también existe un epiplón que conecta el bazo con el estómago.

Un epiplón o un meso es siempre una doble lámina que contiene un vaso en el medio. En el movimiento de desarrollo, se producen pliegues y una reorganización, permitiendo que el epiplón, por ejemplo el meso, se desplace hacia un lado. Esto forma una **fascia de coalescencia**, que puede ser resecada por los cirujanos sin problema, ya que no hay vasos. Un meso, en cambio, siempre contiene un vaso, mientras que un ligamento o una fascia no necesariamente contienen vasos.

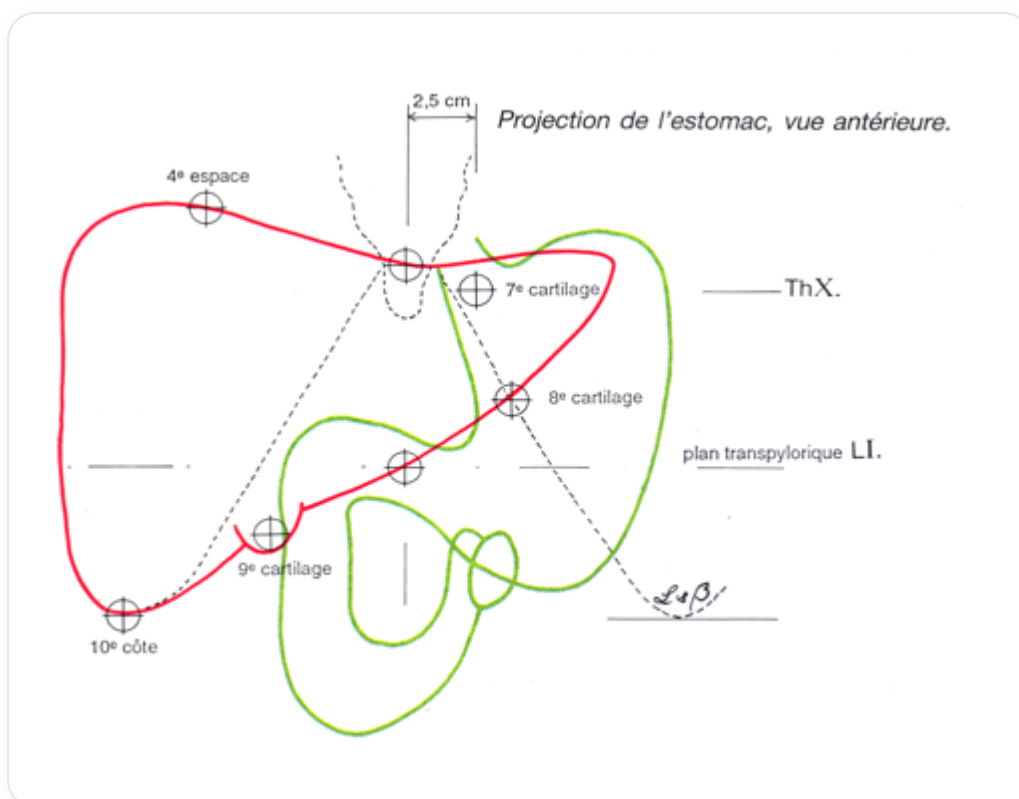


FIG. — *Proyección estomacal anterior*

A nivel del peritoneo, tenemos el **mesodermo**, la **somatopleura**, la **esplanchnopleura**, así como el **mesogastrio** ventral y dorsal. También tenemos mesos, fascias, **omentos** (epiplones) y ligamentos. Todo esto constituye el peritoneo, organizado en la cavidad peritoneal.

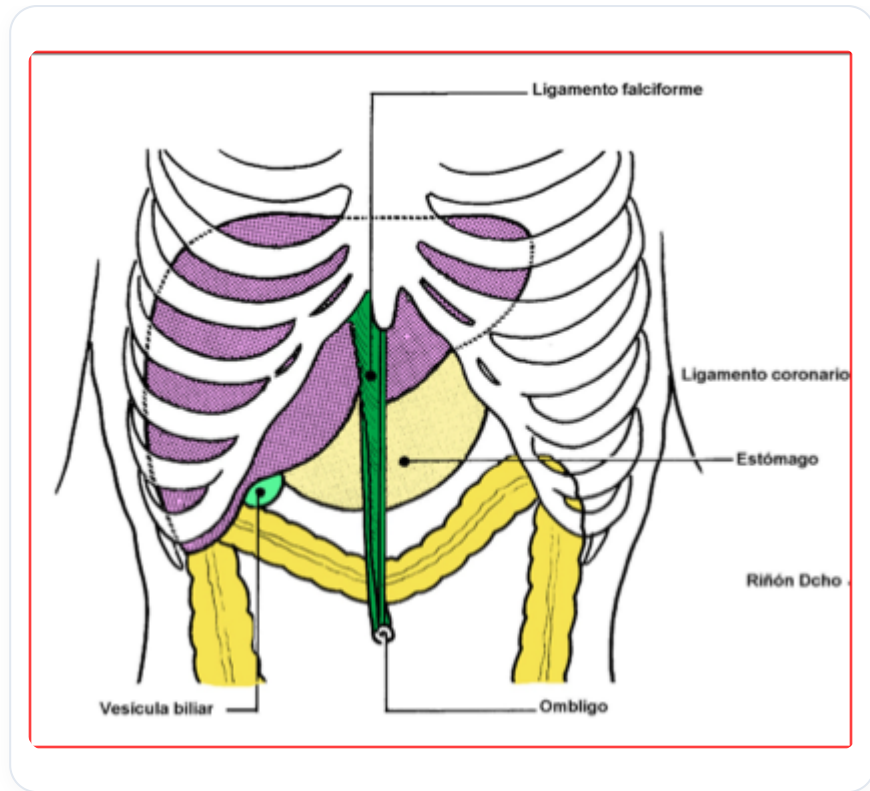


FIG. — Anatomía abdominal superior

El intestino comienza a crecer, el hígado se desarrolla, el estómago quiere expresarse y los pulmones empujan. Todo esto debe encontrar su lugar.

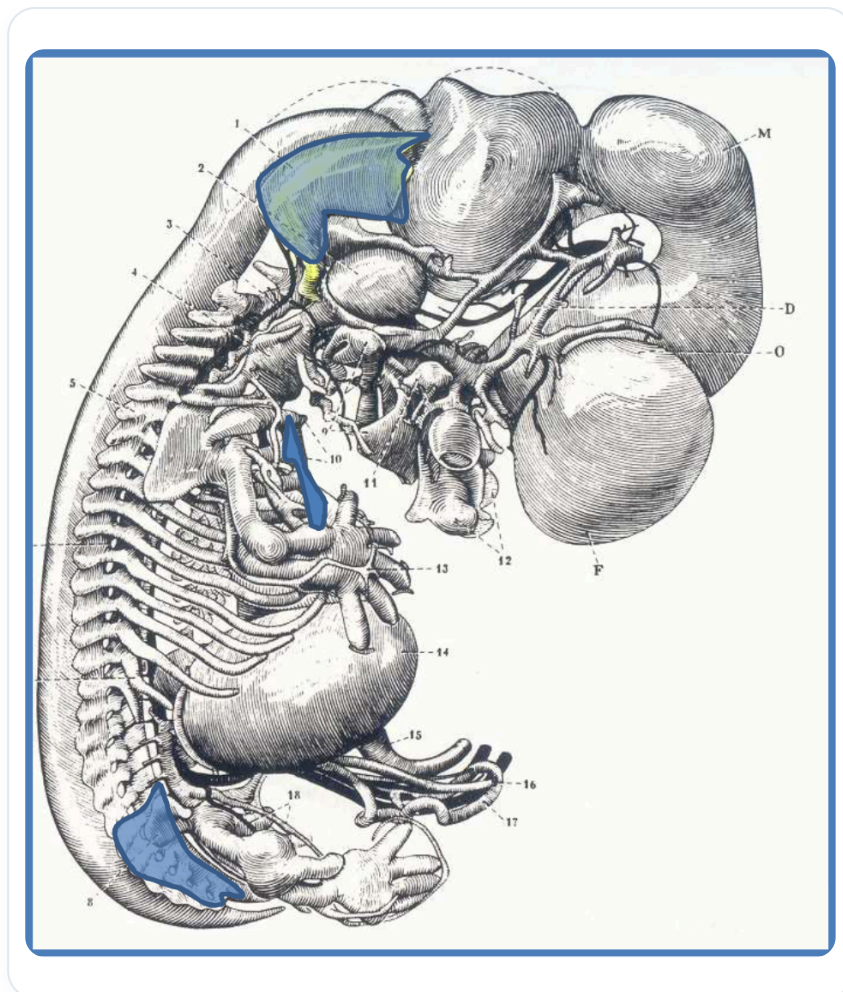
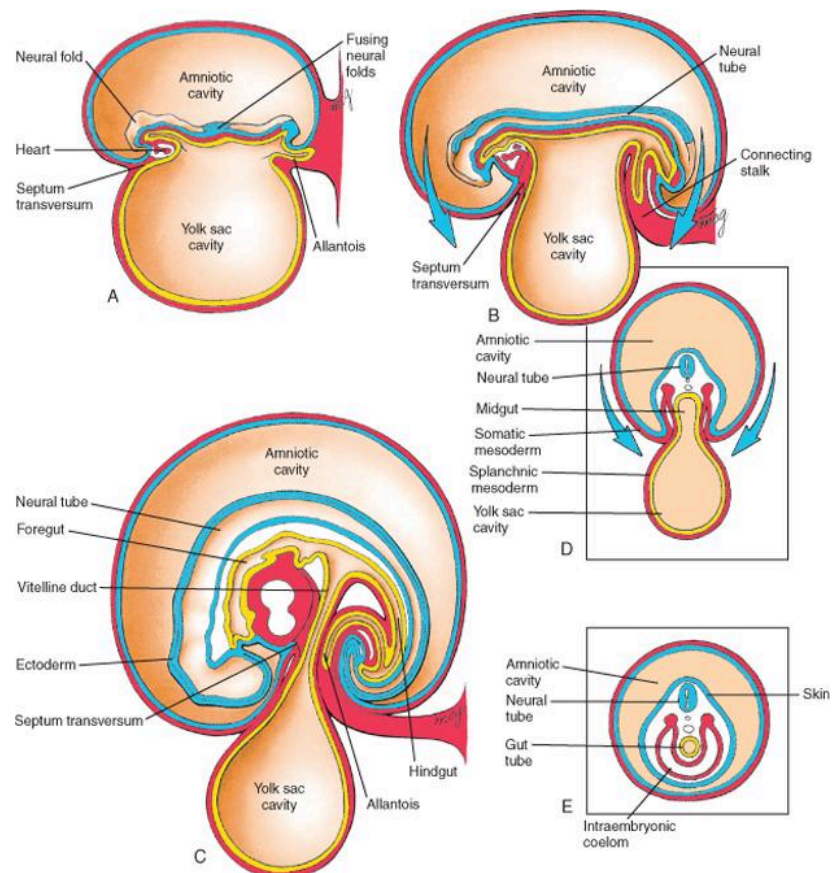


FIG. — Embrión humano, órganos



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Plegamiento embrionario lateral/cráneo-caudal

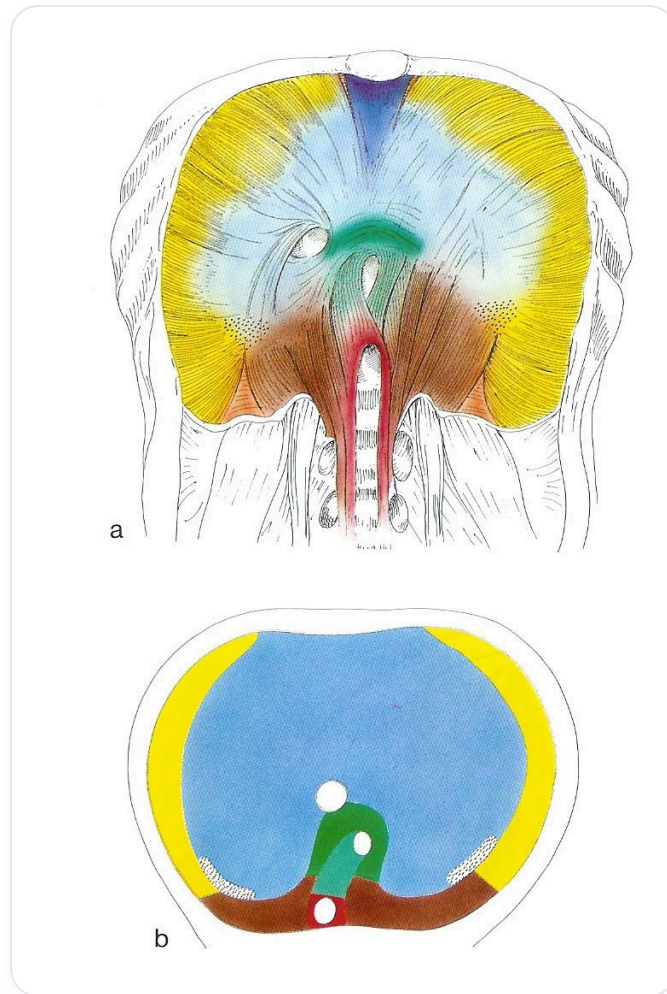


FIG. — Diafragma humano

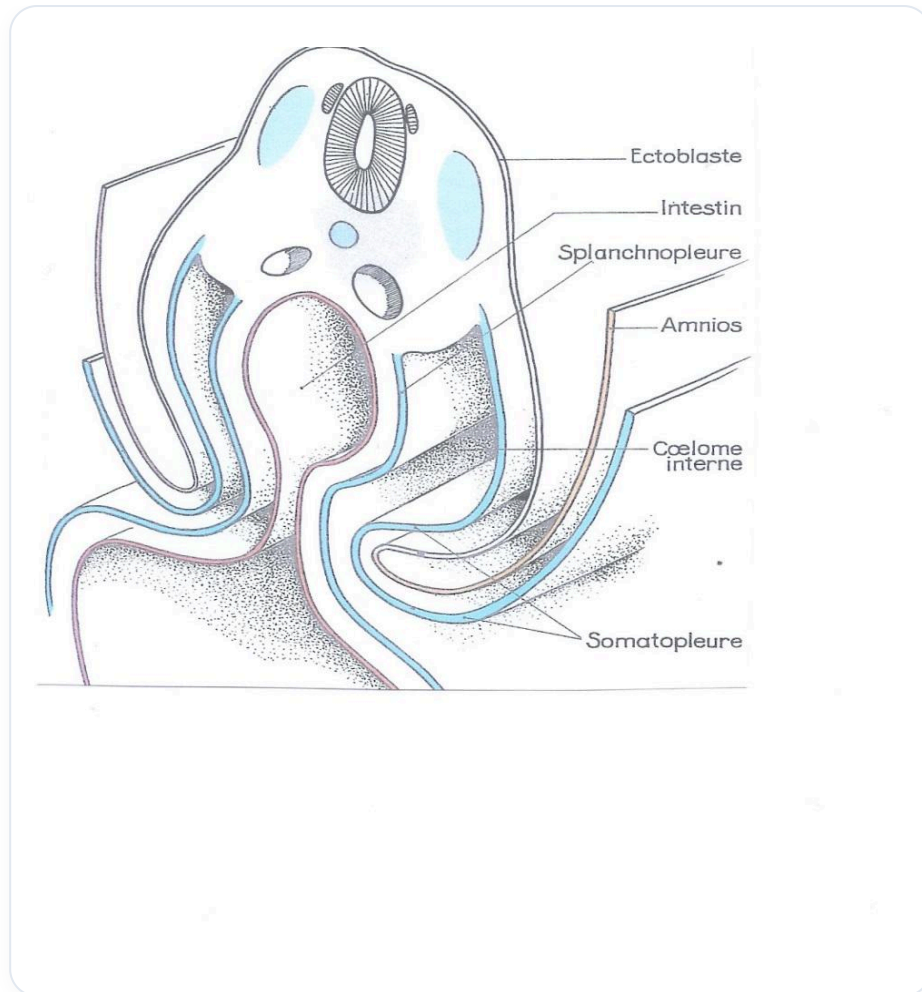


FIG. — *Plegamiento embrionario lateral*